

GUIA TÉCNICO-PRÁTICO · OUTUBRO DE 2026

Brain Capital

Guia Escutaris · Método CUIDAR

Da saúde mental ocupacional à estratégia integrada de cuidado, competências e resultados

Concepção editorial: **Escutaris**
Coordenação: **Dra. Ana Paula Teixeira**

ESCUTARIS

NESTE GUIA

Sumário

01 **Entender o conceito**
O que é Brain Capital, o que não é, e onde encontra a saúde ocupacional

02 **O método CUIDAR**
Seis etapas operacionais, da alta liderança à revisão

03 **Diagnóstico dos fatores psicossociais**
Olhar para a organização real do trabalho

04 **Lideranças**
Avaliar competências, capacitar e reavaliar

05 **Medir e interpretar**
Indicadores, leitura de resultados e o que o mundo já mede

06 **Implantação**
Os primeiros 90 dias, a continuidade em 12 meses e a série em vídeo

+ **Referências e leituras de origem**
As fontes que sustentam este guia

CONCEPÇÃO EDITORIAL
Escutaris

COORDENAÇÃO
Dra. Ana Paula Teixeira

EDIÇÃO
Outubro de 2026

IMAGENS
Ilustrativas, geradas por inteligência artificial



CAPÍTULO 01

Entender o conceito

Este guia traduz *Brain Capital* para decisões organizacionais, sem propor substituir a Medicina do Trabalho, a gestão de riscos ocupacionais ou práticas consolidadas de cuidado.

Apresentação

Brain Capital, ou Capital Cerebral, junta saúde cerebral, habilidades cognitivas, emocionais e sociais e as condições que permitem desenvolvê-las.

> Promover capacidades humanas é inseparável de prevenir condições de trabalho nocivas, proteger a dignidade e desenvolver lideranças capazes de gerir fatores psicossociais.

O objetivo não é exigir um cérebro "perfeito" nem transformar doenças em métricas de valor individual.

O que é Brain Capital, e o que não é

1

Saúde cerebral

Saúde mental e neurológica, funcionamento e possibilidade de participação social e laboral ao longo da vida.

2

Habilidades cerebrais

Atenção, aprendizagem, adaptação, criatividade, resolução de problemas e competências socioemocionais.

3

Determinantes

Condições de educação, trabalho, renda, proteção social, serviços de saúde e ambiente.

Adaptado de Ayadi, Eyre e colaboradores, Brookings (2023).

Uma pessoa com depressão, insônia, sequelas de AVC ou outra condição neurológica não perde automaticamente sua contribuição humana e profissional. Ações de cuidado, acessibilidade, recuperação, adaptações razoáveis e ambientes saudáveis fazem parte da resposta.

Brain Capital e Saúde Ocupacional: convergência e diferença

DIMENSÃO	SAÚDE MENTAL OCUPACIONAL	BRAIN CAPITAL
Finalidade	Prevenir agravos e promover saúde no trabalho	Integrar saúde cerebral e capacidades humanas ao desenvolvimento social e econômico
Escopo	Riscos do trabalho, adoecimento, prevenção e reabilitação	Saúde, habilidades e seus determinantes, inclusive fora da empresa
Ferramentas	Avaliação de riscos, vigilância, intervenções e liderança	Pode integrar as mesmas ferramentas a educação, inovação e indicadores econômicos
Cuidado crítico	Proteção dos trabalhadores	Evitar tratar capacidades cerebrais apenas como ativo produtivo

A novidade principal está no enquadramento econômico e na amplitude intersetorial, não necessariamente nas intervenções. Um programa corporativo tradicional, se completo e articulado, pode contemplar boa parte das ações propostas sob a expressão *Brain Capital*.



CAPÍTULO 02

O método CUIDAR: seis etapas operacionais

CUIDAR é uma estrutura didática proposta para este guia. Não constitui escala validada nem substitui os procedimentos e obrigações legais aplicáveis.

C

Comprometer a alta liderança

Criar patrocinador executivo, comitê multidisciplinar, orçamento, metas e regras éticas.

U

Unificar informações

Mapear fontes de RH, SST, saúde ocupacional, operações, qualidade e treinamento; estabelecer padrões e proteção de dados.

I

Identificar riscos e capacidades

Avaliar fatores psicossociais relacionados ao trabalho, necessidades de adaptação e oportunidades de aprendizagem.

D

Desenvolver pessoas e ambientes

Priorizar mudanças organizacionais; capacitar e avaliar lideranças; oferecer suporte proporcional às necessidades.

A

Acompanhar indicadores

Construir séries históricas, fichas técnicas, linhas de base e reuniões de análise.

R

Revisar e transformar

Corrigir intervenções, avaliar efetividade, escutar trabalhadores e prestar contas à governança.



CAPÍTULO 03

Diagnóstico dos fatores psicossociais

O diagnóstico deve examinar a organização real do trabalho, não apenas sinais ou sintomas individuais.

As seis áreas do HSE (demandas, controle, apoio, relacionamentos, papel e mudanças) são um referencial útil, complementado pelas características da atividade, pelo contexto e pelas exigências brasileiras.

Passo a passo

- Caracterizar unidades, atividades, funções, turnos e grupos de exposição.
- Revisar informações já disponíveis e consultar trabalhadores e representantes.
- Selecionar instrumentos apropriados e métodos qualitativos; verificar adequação de uso e interpretação.
- Identificar fontes de exposição, severidade, grupos afetados e controles existentes.
- Priorizar medidas de prevenção, com responsáveis, prazo, recursos e evidências de execução.
- Incorporar resultados ao processo de GRO/PGR quando aplicável e reavaliar a efetividade.

QUEM FAZ O QUÊ

A Escutaris pode apoiar o diagnóstico psicossocial e as devolutivas. **A responsabilidade de organizar e executar o gerenciamento de riscos permanece com a organização e seus responsáveis técnicos.** Consulte a NR-1 vigente, os guias e as perguntas e respostas do MTE.

CAPÍTULO 04

Lideranças: avaliar competências, capacitar e reavaliar

A liderança atua sobre cargas, prioridades, comunicação, autonomia, conflitos e acolhimento.

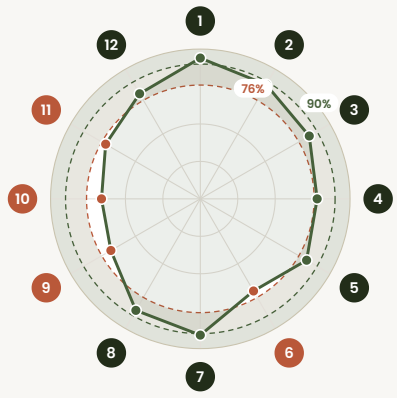
> Um treinamento isolado não é sinônimo de competência demonstrada.

- Definir comportamentos observáveis de prevenção do estresse e de apoio à equipe.
- Aplicar ferramentas adequadas de autoavaliação e, quando pertinente, feedback da equipe, protegendo o anonimato.
- Construir devolutiva individual e plano de desenvolvimento com metas comportamentais.
- Capacitar líderes em comunicação, gestão de demandas, conflitos, reconhecimento e encaminhamento adequado.
- Observar mudanças comportamentais e reavaliar em prazo pactuado.

RADAR DE COMPETÊNCIAS DA LIDERANÇA

A Escutaris mapeia a competência dos líderes em gerenciar estressores psicossociais pelo **Radar de Competências da Liderança**. Acesse o site e agende a sua autoavaliação.

escutaris.com.br



EXEMPLO DE DEVOLUTIVA · DADOS FICTÍCIOS

1	Integridade	94%
2	Gerenciamento de emoções	88%
3	Abordagem ponderada	84%
4	Gestão proativa do trabalho	78%
5	Solução de problemas	82%
6	Participativo e empoderador	71%
7	Acessibilidade pessoal	91%
8	Sociável	86%
9	Engajamento empático	69%
10	Gestão de conflitos	66%
11	Uso de recursos organizacionais	73%
12	Assumir a resolução de problemas	81%

90% ou mais: eficaz · 76% a 89%: razoável · até 75%: necessita desenvolvimento

Leitura fictícia no Radar de Competências da Liderança, da Escutaris. Base: SMCIT (*Stress Management Competency Indicator Tool*), Health and Safety Executive, Reino Unido.

CAPÍTULO 05

Medir e interpretar

Indicadores com fonte, responsável e regra de acesso, lidos ao longo do tempo e sem pressa de afirmar causa.

Indicadores: o que medir e quem cuida

INDICADOR	FONTE / COLETA	ÁREA GUARDIÃ
Exposição psicossocial	Pesquisa válida + avaliação do trabalho + entrevistas; por grupo protegido	SST / RH / trabalhadores
Competências das lideranças	Instrumento apropriado, feedback e ações observáveis	RH / desenvolvimento / SST
Dias de ausência por trabalhador	Dias de ausência ÷ efetivo médio do período	RH / Saúde Ocupacional
Afastamentos	Frequência, duração e tendência em dados agregados	Saúde Ocupacional / RH
Presenteísmo	Instrumento apropriado, voluntário e confidencial	Saúde Ocupacional / pesquisa
Rotatividade voluntária	Saídas voluntárias ÷ efetivo médio	RH / controladoria
Clima ético e segurança psicológica	Questionários adequados e escuta qualitativa	RH / compliance
Sono e fadiga	Escalas adequadas + jornada + turnos	SST / operações / saúde
Aprendizagem	Competências adquiridas e aplicação posterior	Educação corporativa
Retorno ao trabalho	Adaptações implantadas e permanência, sem identificar diagnósticos	Saúde Ocupacional / RH
Qualidade e produtividade	Indicadores próprios da atividade, contextualizados	Operações / qualidade
Inovação	Melhorias implantadas e avaliadas	Estratégia / inovação

FICHA DE CADA INDICADOR

Documentar: definição; numerador e denominador; população; período; fonte; responsável; periodicidade; limites; metas; regras de acesso. **Não expor dados clínicos individuais em painéis gerenciais.** Em equipes pequenas, evitar a desagregação que possibilite reidentificação.

COMUNIDADE ESCUTARIS

Consulte na **Comunidade Escutaris** alguns indicadores sugeridos para avaliar a saúde mental no trabalho.

comunidade.escutaris.com

Como interpretar resultados

Comece por uma linha de base e diferencie quatro tipos de indicador: de **atividade** (por exemplo, número de palestras), de **processo** (percentual de ações implantadas), de **resultado** (melhora nas condições de trabalho) e de **impacto** (mudanças sustentadas em saúde ou desempenho).

Compare os resultados ao longo do tempo, considerando sazonalidade, rotatividade, mudanças de registro e outras intervenções simultâneas.

ROI ESTIMADO

ROI (%) = [(**benefícios monetizados** − custo do programa) ÷ custo do programa] × 100

Sempre declarar premissas, intervalos de incerteza e efeitos não monetizados; não afirmar causalidade por mera coincidência temporal.

PAINEL DE PRÁTICAS

As ações propostas realmente funcionam? Se estiver em dúvida, consulte o nosso **painel de práticas**. Afinal, não é sobre o que você acredita que dará resultado, mas sobre o que de fato agregará valor às pessoas, aos negócios e à sociedade. E isso só acontece a partir de práticas testadas e validadas.

escutaris.com.br

O que o mundo já mede

O *Global Brain Capital Dashboard*, apresentado em 2023 por Ayadi, Eyre e colaboradores, articula pilares como fatores determinantes, saúde cerebral e habilidades cerebrais, e se destina a monitorar tendências e subsidiar políticas. Índices comparativos entre países não equivalem à comprovação de que políticas nacionais produziram ganhos causais.

Há esforços internacionais de mensuração e articulação política. Antes de citar rankings, verifique no painel primário a edição, a cobertura geográfica, os anos dos dados, os pesos, as lacunas e a metodologia. Classificação nacional ou ganho percentual só entra com checagem documental específica.

CAPÍTULO 06

Implantação em 90 dias, e continuidade em 12 meses

O que entregar em cada janela e qual decisão a governança precisa tomar ao fim dela.

Dias 1 a 30	ENTREGAS MÍNIMAS Governança, inventário de dados, mapa de unidades, planejamento do diagnóstico	DECISÃO ESPERADA Aprovar escopo, recursos e proteção de dados
Dias 31 a 60	ENTREGAS MÍNIMAS Diagnóstico, escuta, priorização e avaliação de lideranças	DECISÃO ESPERADA Definir medidas primárias e responsáveis
Dias 61 a 90	ENTREGAS MÍNIMAS Primeiras intervenções, dashboard, devolutivas e revisão	DECISÃO ESPERADA Decidir continuidade e correções
Trimestral A PARTIR DO 4º MÊS	ENTREGAS MÍNIMAS Conferência de execução, indicadores e qualidade da evidência	DECISÃO ESPERADA Revisar prioridades e ajustes
Anual FECHA O CICLO	ENTREGAS MÍNIMAS Avaliação integrada, prestação de contas e novo ciclo	DECISÃO ESPERADA Replanejar investimentos e controles

SOBRE OS PRAZOS

Estes prazos são sugeridos. Dependem do nível de complexidade da empresa e da validação do projeto pela alta liderança ou por seu representante.

A série em vídeo: oito pautas

01 **Por onde começar?**
Governança e piloto de 90 dias

02 **Sua empresa conhece os riscos psicossociais?**
Diagnóstico e priorização

03 **Seu líder sabe prevenir o estresse?**
Competência, desenvolvimento e reavaliação

04 **Quais indicadores realmente mostram cuidado?**
Painel de coleta e responsabilidade

05 **Como desenvolver o cérebro sem sobrecarregá-lo?**
Fadiga, aprendizagem e inclusão

06 **Cuidar das pessoas gera resultados financeiros?**
Custos e avaliação de benefícios

07 **Quais países já medem o capital cerebral?**
Leitura crítica de dashboards

08 **Do diagnóstico à transformação: qual é o método?**
Plano integrado de 12 meses

PARA IR ALÉM

Referências e leituras de origem

1. AYADI, R. et al. *The global brain capital dashboard*. Brookings, 26 set. 2023. brookings.edu/articles/the-global-brain-capital-dashboard

2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO guidelines on mental health at work*. Genebra: OMS, 2022. who.int/publications-detail-redirect/9789240053052

3. HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. *Management Standards*. hse.gov.uk/stress/standards/overview.htm

4. HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. *Line Manager Competency Indicator Tool*. hse.gov.uk/stress/mcit.htm

5. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1, versão vigente e materiais oficiais. gov.br/trabalho-e-emprego · NR-1

6. EURO-MEDITERRANEAN ECONOMISTS ASSOCIATION. *Brain Capital Dashboard and Index*. research.euromed-economists.org/brain-capital-dashboard-and-index

7. ESCUTARIS. Saúde mental corporativa e soluções organizacionais. escutaris.com.br

Sobre a Escutaris

A Escutaris desenvolve soluções de diagnóstico e apoio à gestão da saúde mental no trabalho, conectando ciência, escuta e decisões. A integração de dados operacionais, estratégias de desenvolvimento e governança exige a participação da organização e das áreas técnicas correspondentes.

NOTA

Material educativo. Não substitui a avaliação de riscos da organização, aconselhamento jurídico, assistência clínica ou avaliação individual. Consulte sempre a versão vigente das normas citadas. Imagens ilustrativas geradas por inteligência artificial.



Ciência que escuta, soluções que transformam.

Diagnóstico psicossocial, avaliação de lideranças e apoio à gestão da saúde mental no trabalho, com base em evidência.

escutaris.com.br
draanapaulateixeira.com.br

ESCUTARIS